HERNIAS, DRENAJES Y OSTOMÍAS

DRA. DEBBIE WONG

FUNCIÓN DE LOS DRENAJES

- Retirar fluidos.
- Aponer tejidos para eliminar espacios potenciales mediante succión.

DRENAJE ABIERTO

- Tubos corrugados o de plástico; el líquido se acumula en gasa o bolsa de ostomía.
- Aumenta el riesgo de infección. Ej.: Penrose.

DRENAJE CERRADO

- Tubos que drenan a una bolsa o reservorio; incluyen drenajes torácicos y abdominales.
- Disminuye el riesgo de infección. Ej.: Jackson-Pratt.

SONDA NASOGÁSTRICA

- Indicaciones: aspiración de jugo gástrico, lavado (intoxicación o sobredosis) y alimentación.
- Complicaciones: epistaxis, aspiración, erosión nasal y nasofaríngea.

CATÉTER URINARIO

- 15–25% de los hospitalizados lo portan; indicado en cirugía, medición de diuresis, retención o incontinencia.
- Complicaciones: traumatismo, uretritis, bacteriuria.

OSTOMÍAS

- Conexión del tracto gastrointestinal a la piel de la pared abdominal: una fístula hecha por el hombre.

GASTROSTOMÍA

- Tubo G: atraviesa la pared abdominal hacia el estómago para drenaje o alimentación.

YEYUNOSTOMÍA

- Tubo hacia el yeyuno para alimentación; puede durar hasta 30 días.
- Menor riesgo de reflujo y de complicaciones que la PEG.

COLOSTOMÍA

- Comunica la mucosa del colon con la pared abdominal para el drenaje de heces.

CECOSTOMÍA

- Tubo utilizado para descomprimir o tratar la incontinencia.

BOLSA DE KOCK

- Ileostomía continente: reservorio hecho con varias asas de íleon.
- El paciente accede a la bolsa de forma intermitente con un catéter o tubo.

COLOSTOMÍA TERMINAL

- El extremo proximal del colon se aboca a la piel para el drenaje de heces.

FÍSTULA MUCOSA

- El extremo distal del colon transectado se lleva a la piel; la mucosa produce moco.

BOLSA DE HARTMANN

- El extremo distal del colon transectado queda en la cavidad peritoneal como un saco ciego.

COLOSTOMÍA EN ASA

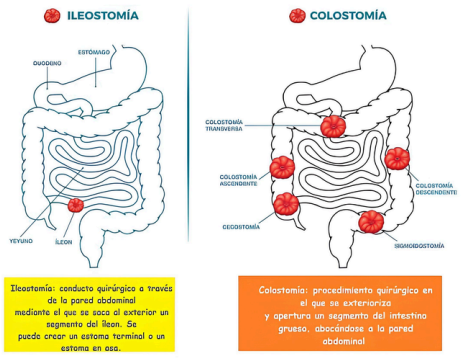
- Se exterioriza un segmento de colon y se mantiene en posición con ayuda de un anillo.

CONDUCTO ILEAL

- La derivación urinaria más común: se reimplantan los uréteres en un segmento de íleon de 18–20 cm, a 15–20 cm de la válvula ileocecal.
- La peristalsis natural ayuda a eliminar la orina.

ILEOSTOMÍA DE BROOKE

- Antes se suturaba la serosa a la piel: el ambiente alcalino del estoma causaba serositis y disfunción.
- Brooke introdujo la eversión de grosor completo de la mucosa suturada a la dermis.



HERNIAS, DRENAJES Y OSTOMÍAS

DRA. DEBBIE WONG

PENROSE

- Drenaje abierto, no aspirativo: fragmento alargado de plástico o goma.
- Facilita la salida de líquido por tensión superficial (capilaridad).

TUBO EN T (KEHR)

- Se coloca en el colédoco y drena bilis a un reservorio mientras se produce la cicatrización.
- Uso temporal tras cirugía de la vía biliar o problemas ureterales.

TUBO PLEURAL

- Indicaciones: neumotórax, hemotórax, derrame pleural, quilotórax y poscirugía torácica.
- Se introduce por un espacio intercostal; permite la reexpansión pulmonar al recuperar la presión negativa.

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (VAC)

- Cicatrización en ambiente estéril; reduce el edema y aumenta la perfusión y el tejido de granulación.
- Disminuye la carga bacteriana y la actividad anaeróbica; acelera la cicatrización.

HEMOVAC

- Tubo delgado con muchos orificios en el extremo, conectado a un reservorio que produce succión.
- Se usa para drenar sangre debajo de la piel.

JACKSON-PRATT

- Tubo plástico conectado a un reservorio; retira el exceso de fluido mediante succión constante.
- Muy usado en cirugía abdominal, mastectomía y cirugía torácica.

COMPLICACIONES INMEDIATAS

- Sangrado.
- Isquemia o necrosis por falla técnica, mucha tensión o poca irrigación.

